جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : اسماء كمال علي حسين
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** حلوان
رقم البطاقة : 28007180103082 **رقم التليفون :** 01111925859 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 18-07-1980 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان القولون
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان القولون
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6159] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: اسماء كمال علي حسين
National ID: 28007180103082

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of colon cancer for Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Pathology Report

Name: اسماء كمال علي

Age: 39 years

Clinical data: polypoidal colonic mass .

Specimen Type: Colonoscopic biopsy.

Date: 22 / 1 /2019

Lab. Number: 43

Hospital Number: 3146/2018

Gross Description:

Two specimens were received disgnated as 1&2:

1/ Multiple grayish white tissue fragments of collective size 1x1 cm. Totally submitted.

2/ Multiple grayish white tissue fragments of collective size 1.5x1.5 cm. Totally submitted

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections examined from.

Specimen 1/ revealed a malignant glandular growth formed of malignant acini lined by pleomorphic hyperchromatic malignant cells. The malignant acini are variable in size and shape, have irregular eccentric lumina and lined by more than layer of cells. Cellular and nuclear atypia are moderate. Mucin activity is absent. No Muscles received to detect invasion.

Specimen 2/ polypectomy specimen received reveals a simple polypoid structure formed of a mixture of hyperplastic pyloric type glandular tissue and intervening oedematous lamina propria containing inflammatory cells and scant smooth muscle. There is no dysplasia or malignancy in sections examined

Diagnosis:

Colonoscopic biopsy.

Specimen 1/ Malignant glandular neoplasm.

Specimen 2/ Hyperplastic polyp.

Comment:

Wider excision to assess invasion as no muscle received in this specimen.

Prof. Dr. Amr El-sebaie

Dr: Marwa Mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: اسماء كمال علي	
MR. : 4580	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient was diagnosed with colon adenocarcinoma in 2009 and underwent a hemicolectomy. In 2018, a local recurrence was identified, prompting a total colectomy with pathology staged as pT3 N1. Postoperatively, the patient received adjuvant therapy with Xeloda (capecitabine) and FOLFORI (5-fluorouracil/leucovorin). The patient completed 9 of the planned 19 cycles of adjuvant chemotherapy and is currently in follow-up. The most recent computed tomography scan shows no evidence of disease. The current plan is continued surveillance.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : حنان عزت شفيق تاودروس

يعتمد ,

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Asmaa Kamal Ali Hussein	Date : 04/06/2024
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 3146/2018	Pat. ID: 11016

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

- **Known case of cancer colon, compared to last CT dated 13-5-2023.**

Findings:

1. **Chest:**

- Mild increase in size of the enlarged right internal mammary lymph nodes the largest measures 10 mm compared to 8 mm.
- Unchanged right lower lobe few tiny subpleural nodular densities, likely non-specific.
- Still noted left lower lung anterior segment calcified nodule.
- No other sizable pulmonary nodules, consolidations, cavitations or bronchiectatic changes.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. **Abdomen and pelvis:**

- Still noted:
  - Enlarged liver showing diffuse hypodense homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
  - Enlarged spleen with normal parenchymal texture with no focal lesions seen. Splenule is seen.
  - Few prominent mesenteric lymph nodes.
  - Thickened left suprarenal gland.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and right suprarenal.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Calcific focus is still seen adherent to the posterior uterine wall likely calcified subserous fibroid.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Midline pelviabdominal scar for previous surgical interference with no underlying enhancing masses.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Asmaa Kamal Ali Hussein	Date : 21/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 3146/2018	Pat. ID: 11016

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

- **Known case of cancer colon, compared to last CT dated 04-6-2024.**

Findings:

1. **Chest:**

Mild increase in size of the enlarged right internal mammary lymph nodes the largest measures 13 x10 mm compared to 10 mm .

Stationary Course regarding :

- Right lower lobe few tiny subpleural nodular densities, likely non-specific.
- Still noted left lower lung anterior segment calcified nodule.
- Right cardiophrenic angle L. N 5mm.
- No other sizable pulmonary nodules, consolidations, cavitations or bronchiectatic changes.
- Few sub Cm mediastinal lymph nodes.
- Small emphysematous bleb 5mm seen at medial segment of right lower lobe .
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. **Abdomen and pelvis:**

- Still noted:
  - Enlarged liver showing diffuse hypodense homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
  - Enlarged spleen with normal parenchymal texture with no focal lesions seen. Splenule is seen.
  - Few prominent mesenteric lymph nodes.
  - Thickened left suprarenal gland.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and right suprarenal.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Calcific focus is still seen adherent to the posterior uterine wall likely calcified subserous fibroid.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Midline pelviabdominal scar for previous surgical interference with no underlying enhancing masses.
- Still noted D2 small lucent lesion.

OPINION:

- **Follow up study showing:**
- **Mild progression of the size of the right internal mammary lymph nodes.**
- **Otherwise, no appreciable changes since the last study.**

DR/Reham Khedr,,MD

Signature Reeham.Khader
25/08/2025 6:32 PM

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Asmaa Kamal Ali Hussein	Date : 04/06/2024
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 3146/2018	Pat. ID: 11016

- Still noted D2 small lucent lesion.

OPINION:

- **Follow up study showing:**
- **Mild increase in size of the right internal mammary lymph nodes.**
- **Otherwise, overall stationary course since the last study.**

Dr. Ali Elsisy, MSc

Signature Dr. Mohamed Mohsen

15/06/2024 03:27 م

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]